ONEMA-POP-020 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

1

ONEMA-POP-020 — Suspeita de Infecção em Feridas e Uso Seguro

de Estratégias Antimicrobianas

1. Identificação institucional, código, título, versão e RT

ONEMA SAÚDE | ONEMA-POP-020 | Suspeita de Infecção em Feridas e Uso Seguro de Estratégias Antimicrobianas |

2. Objetivo e abrangência

Reconhecer sinais clínicos de infecção em feridas, estratificar gravidade e encaminhar sem uso antimicrobiano indiscriminado.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado, com treinamento e atuação dentro das competências profissionais. Feridas agudas/crônicas; classificação específica de pé diabético conforme IWGDF/IDSA quando aplicável; prescrição antibiótica não é ato automático do POP.

4. Materiais, equipamentos e responsável pelo fornecimento

Paciente: curativos e prescrições atuais; enfermeiro: EPI, material de limpeza/avaliação, termômetro, instrumentos de medida e documentação. Fornecimento pactuado no pedido e confirmado antes da visita.

5. Avaliação clínica e preparação

Avaliar etiologia, duração, mudança de exsudato, calor, rubor, edema, dor, purulência, odor após limpeza, profundidade, perfusão, diabetes e sinais sistêmicos.

6. Execução técnica numerada e verificável

1. Confirmar identidade, histórico, alergias e tratamento antimicrobiano prévio.

2. Aferir sinais vitais conforme avaliação e investigar calafrios, confusão, hipotensão, taquicardia e deterioração geral.

3. Inspecionar ferida após limpeza e comparar com registros prévios: aumento de dor, eritema, calor, edema, pus,

extensão e profundidade.

4. Diferenciar colonização de infecção clínica; odor isolado ou cultura positiva isolada não confirma infecção.

5. Em pé diabético, classificar gravidade clínica conforme IWGDF/IDSA; considerar isquemia e neuropatia que podem

mascarar sinais.

6. Verificar sinais de abscesso, necrose, celulite extensa, comprometimento profundo e suspeita de osteomielite.

7. Não iniciar antibiótico tópico ou sistêmico apenas para acelerar cicatrização de ferida não infectada; contatar prescritor

diante de suspeita fundamentada.

8. Realizar cobertura e proteção compatíveis com plano existente, sem mascarar progressão clínica.

9. Comunicar achados estruturados e urgência ao RT/prescritor; documentar evolução, fotografias autorizadas e retorno.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Sepse suspeita, celulite rapidamente progressiva, gangrena, necrose profunda, crepitação, isquemia importante, febre com instabilidade: urgência/SAMU 192 conforme gravidade.

8. Cuidados posteriores e orientações

Orientar não automedicar com antibióticos, vigiar expansão do eritema, febre, dor e secreção; retorno programado com critérios objetivos.

9. Registros obrigatórios na Carteira Digital ONEMA

Identificação e consentimento; avaliação inicial e sinais vitais quando indicados; descrição objetiva, classificação/medidas,

intervenção, insumos, resposta, intercorrências, orientações, comunicação e plano de seguimento; assinatura profissional

e trilha de auditoria.

2

10. Referências técnicas específicas e rastreáveis

IWGDF/IDSA — Diabetic Foot Infections 2023 — https://www.idsociety.org/practice-guideline/diabetic-foot-infections/

Sociedade Brasileira de Diabetes — Infecção no pé, diretriz 2026 —

https://diretriz.diabetes.org.br/diagnostico-e-tratamento-da-infeccao-no-pe-de-pessoas-com-diabetes/